

TEMA 9.49 • RESPIRATORIO

Amigdalectomía

PERFIL EUNACOM 1.04.1.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a la Amigdalectomía

La **amigdalectomía** es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en la práctica otorrinolaringológica, especialmente en pediatría. Aunque tradicionalmente se asociaba casi exclusivamente a infecciones recurrentes, las indicaciones han evolucionado. Actualmente, se dividen en tres grandes grupos: **infecciosas, obstructivas y neoplásicas**.

Es fundamental recordar que la mayoría de los cuadros de amigdalitis tienden a autolimitarse o disminuir su frecuencia con el paso de los años, por lo que la decisión quirúrgica debe basarse en criterios objetivos y no en eventos aislados.

1. Indicaciones Infecciosas

Este grupo incluye a pacientes que sufren de infecciones bacterianas a repetición que impactan significativamente su calidad de vida.

Amigdalitis Recurrente (Criterios de Paradise)

Para considerar la cirugía por recurrencia, se deben cumplir estrictamente los siguientes criterios de frecuencia (conocidos como la regla del 7-5-3):

TABLA 9.49.1: PERIODO DE TIEMPO VS FRECUENCIA DE EPISODIOS BACTERIANOS

PERIODO DE TIEMPO	FRECUENCIA DE EPISODIOS BACTERIANOS
En el último año	7 o más episodios
En los últimos 2 años	5 o más episodios por año
En los últimos 3 años	3 o más episodios por año

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Para que estos episodios cuenten para la cirugía, deben ser **amigdalitis bacterianas comprobadas** (idealmente con test rápido de antígeno o cultivo para *Streptococcus pyogenes* positivo) y haber recibido tratamiento antibiótico completo y adecuado.

Absceso Periamigdalino

El **Flegmón y Absceso Periamigdalino** es una complicación supurativa local. - La indicación quirúrgica estándar suele ser tras **2 o más episodios** de absceso periamigdalino. - Algunos especialistas consideran la cirugía tras el primer episodio si existen otros factores de riesgo o recurrencia infecciosa previa.

Amigdalitis Crónica

Se define como una inflamación de las amígdalas que persiste por **3 meses o más**. - Se caracteriza por dolor de garganta persistente, halitosis, formación de caseum (tonsilolitos) y adenopatías cervicales. - La indicación quirúrgica surge cuando el cuadro **no responde al tratamiento médico** bien llevado (antibióticos y medidas de higiene).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡Cuidado! No se debe indicar cirugía basándose solo en el relato de los padres. Los episodios deben ser documentados por un médico, verificando la presencia de exudado, adenopatías y fiebre, para asegurar que no se trata de cuadros virales banales.

2. Indicaciones Obstructivas

Hoy en día, las causas obstructivas son la **indicación más frecuente** de amigdalectomía (generalmente asociada a adenoidectomía). Se deben a

una **hipertrofia amigdalina** grado III o IV que genera compromiso mecánico.

- **Síndrome de Apnea/Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS):** Es la indicación principal. El paciente presenta ronquido estridente, pausas respiratorias durante el sueño, sueño fragmentado y, en niños, irritabilidad o bajo rendimiento escolar.
- **Disfagia obstructiva:** Amígdalas tan grandes que dificultan el paso del bolo alimenticio, provocando lentitud al comer o rechazo a ciertos alimentos sólidos.
- **Trastornos del lenguaje:** En raras ocasiones, la hipertrofia masiva puede causar una "voz de papa caliente" persistente.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología del SAHOS en niños suele ser puramente mecánica por hipertrofia del tejido linfóide (amígdalas y adenoides), a diferencia del adulto donde influyen más el colapso de la vía aérea y la obesidad. Por ello, la cirugía es altamente curativa en la población pediátrica.

3. Sospecha de Neoplasia

Ante la sospecha de un proceso maligno, la amigdalectomía se realiza con fines diagnósticos y terapéuticos (biopsia excisional).

- **Asimetría amigdalina significativa:** Una amígdala notablemente más grande que la otra, especialmente si presenta un crecimiento rápido o cambios en la mucosa (ulceraciones).
- **Clínica sugerente de Linfoma:** Presencia de síntomas B (fiebre, sudoración nocturna, baja de peso) asociada a aumento de volumen amigdalino asimétrico.
- **Carcinoma espinocelular:** Más común en adultos con factores de riesgo (tabaco, alcohol, VPH).

Requisitos para la indicación quirúrgica

- Para que un paciente sea candidato a cirugía por causas infecciosas, el médico debe verificar:
- **Evaluación objetiva:** Los cuadros fueron evaluados por un profesional y no son simples resfriados virales.
- **Tratamiento antibiótico adecuado:** Se debe confirmar que el paciente completó los cursos de antibióticos (ej. 10 días de Amoxicilina).
- - Si el paciente tomó antibióticos solo por 2 o 3 días y suspendió al sentirse bien, es probable que no haya habido erradicación del **Streptococcus pyogenes**, favoreciendo la recurrencia. En este caso, la falla es del tratamiento y no necesariamente una indicación quirúrgica inmediata.

Resumen de Indicaciones (Tabla)

TABLA 9.49.2: CATEGORÍA VS INDICACIÓN PRINCIPAL		
CATEGORÍA	INDICACIÓN PRINCIPAL	DETALLE CLAVE
Infeciosa	Amigdalitis recurrente	Criterios de Paradise (7-5-3).
Infeciosa	Absceso periamigdalino	Generalmente ≥ 2 episodios.
Infeciosa	Amigdalitis crónica	> 3 meses sin respuesta a tratamiento.
Obstructiva	SAHOS	Causa más frecuente actualmente.
Obstructiva	Disfagia	Por hipertrofia grado III-IV.
Neoplásica	Sospecha de cáncer	Asimetría amigdalina o sospecha de linfoma.

EUNACOM CRITERIOS

Ante un paciente con amigdalitis recurrente que no cumple estrictamente los criterios de Paradise, la conducta inicial siempre debe ser la observación y el manejo médico óptimo, ya que la tendencia natural de este tejido es a la involución con la edad.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Padres consultan porque su hijo de 6 años ha tenido múltiples episodios de odinofagia con fiebre en el último año. Refieren 8 episodios, pero solo en 3 de ellos acudieron al médico y recibieron tratamiento antibiótico completo, los demás fueron manejados en casa con antiinflamatorios. ¿Está indicada la amigdalectomía?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Amigdalectomía. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Indicaciones de amigdalectomía: infecciosas (más importante: recurrencia), obstructivas (actualmente las más frecuentes) y sospecha de cáncer.
- Amigdalitis recurrente: 7 episodios bacterianos en 1 año, O 5/año × 2 años, O 3/año × 3 años.
- Los episodios deben ser amigdalitis BACTERIANAS confirmadas con evaluación médica objetiva + antibiótico completo.
- Si no se completó el tratamiento antibiótico (10 días amoxicilina), la recurrencia probablemente es por falta de erradicación, no indicación quirúrgica.
- Abscesos periamigdalinos: se requieren 2 o más para indicar amigdalectomía (mayoría de autores).
- Amigdalitis crónica: duración ≥3 meses sin respuesta a tratamiento antibiótico adecuado.
- Indicaciones obstructivas: hipertrofia amigdalina + síntomas (apnea obstructiva del sueño, disfagia).
- Sospecha de cáncer: amígdala muy asimétrica con clínica de linfoma → amigdalectomía para biopsia.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (AMIGDALECTOMÍA)

PREGUNTA 1

Padres consultan porque su hijo de 6 años ha tenido múltiples episodios de odinofagia con fiebre en el último año. Refieren 8 episodios, pero solo en 3 de ellos acudieron al médico y recibieron tratamiento antibiótico completo, los demás fueron manejados en casa con antiinflamatorios. ¿Está indicada la amigdalectomía?

- A) Sí, porque tuvo más de 7 episodios en un año
- B) No, porque solo 3 episodios fueron documentados médicamente con tratamiento completo
- C) Sí, porque la recurrencia indica fracaso del tratamiento médico
- D) Sí, si la madre confirma que siempre tuvo exudado amigdalino
- E) No, porque la amigdalectomía solo se indica en adultos

PREGUNTA 2

Niño de 5 años con ronquido nocturno severo, pausas respiratorias observadas por los padres y somnolencia diurna. Al examen se observan amígdalas palatinas hipertróficas grado IV que se tocan en la línea media. ¿Cuál es la indicación de amigdalectomía en este caso?

- A) No hay indicación; se debe esperar a que las amígdalas involucionen con la edad
- B) Indicación obstructiva: hipertrofia amigdalina con síndrome de apnea obstructiva del sueño
- C) Indicación infecciosa: las amígdalas grandes se infectan con mayor frecuencia
- D) Se debe realizar primero una polisomnografía y solo operar si confirma apnea severa
- E) Indicación por sospecha de cáncer: las amígdalas tan grandes pueden ser un linfoma

PREGUNTA 3

Paciente de 25 años con dos episodios de absceso periamigdalino en los últimos 8 meses, ambos drenados quirúrgicamente. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Observación y manejo conservador con antibióticos profilácticos
- B) Amigdalectomía programada
- C) Esperar un tercer episodio antes de indicar cirugía
- D) Amoxicilina-ácido clavulánico por 21 días como erradicación
- E) TAC de cuello para descartar cáncer antes de decidir

RESUMEN: AMIGDALECTOMÍA

La amigdalectomía tiene indicaciones bien definidas que se dividen en tres grupos: infecciosas, obstructivas y por sospecha de cáncer. Actualmente, las indicaciones obstructivas son las más frecuentes, superando a las infecciosas. Dentro de las indicaciones infecciosas, la más importante es la amigdalitis recurrente, que requiere un número elevado de episodios bacterianos documentados: 7 amigdalitis bacterianas en 1 año, o 5 por año durante 2 años consecutivos, o 3 por año durante 3 años consecutivos. Es fundamental que los episodios sean amigdalitis bacterianas confirmadas con evaluación médica objetiva y que hayan recibido tratamiento antibiótico completo (no basta con lo que refieran los padres). Si no se completaron los 10 días de amoxicilina, la recurrencia probablemente se debe a falta de erradicación del *Streptococcus pyogenes*. Otras indicaciones infecciosas incluyen 2 o más abscesos periamigdalinos y la amigdalitis crónica (duración de 3 meses o más sin respuesta a tratamiento antibiótico adecuado). Las indicaciones obstructivas requieren hipertrofia amigdalina más síntomas obstructivos como síndrome de apnea obstructiva del sueño o disfagia por el tamaño amigdalino. La sospecha de cáncer, como una amígdala muy asimétrica con clínica sugerente de linfoma, también es indicación de cirugía con biopsia posterior.